

監所關注小組 Prison Watch

[所有文章](#)[活動新訊](#)[活動紀錄](#)[小組觀點](#)[監所新知](#)[電子刊物](#)[監所脫殼](#)[更多](#)[Q](#)

Prison Watch · 2025年5月26日

DAY6 | 2025年4月30日 (三) 第六次審判期日

證據調查程序

適應障礙症但有憂鬱情緒 / 憂鬱症
反覆性依附障礙症 / 創傷後壓力症
很可能符合 (資料不足) 很可能符合 (資料不足)

鑑定分析總結：

- 一、大量多主之人証、物証支持A童確美於被告全時照顧時遭受長期嚴重多重虐待
- 二、生前自白書精神部分所以回述
- 三、創傷後壓力症分析

0950 轉証人吳姓
林姓(本于滑)：可否理解為很多精神科 Dr. 的老師是
你已交的報告已獲得中心認可出報告→是

證據調查程序

鑑定人：丘彥南醫師
被告：劉彩萱、劉若琳

09:07 續行審理

檢察官欲提供由周保母拍攝之甲證85調查（照片提示），描述衣服等。
審判長制止，由鑑定人來說明。

丘彥南醫師鑑定人員結

壹、解說先行：
一、鑑定人及鑑定報告簡介：2022年退休，台灣兒童青少年精神醫學會顧問（前理事長2006-2010），成立司法精神鑑定委員會、中華心理衛生協會理事、台灣司法精神醫學會監事，主責兒少司法精神鑑定逾百例。說明兒少司法精神鑑定基本倫理、原理、原則。鑑定程序包括：1.傷勢鑑定討論（113年12月13日 8:15-9:40）、2.全偵查卷宗與資料（包括影音）、依據資料等。

二、精神鑑定結果：
A童受凌虐都符合，並高度懷疑有性虐待。

三、兒少身體虐待定義（兒少虐待及疏忽：醫事人員工作手冊，第二版）
（一）疏忽的定義
（二）性虐待的定義

四、本案A童受到精神虐待的樣態
（一）Mira證詞裡，恐懼等描述
（二）隔離／威脅／長時間罰站／限制行動，體罰不讓A與他人溝通互動，長期、長時間令A童罰站，導致腳水腫；手揹在背後（兩位被告互相傳訊息內容）；精神加身體虐待，綑綁A童身體軀幹及四肢，置放於磨石子地板；A童閉眼或無神
（三）嚴重疏忽部分：乙地電腦間有許多電線等、甲地罰站處有瓦斯桶等
（四）精神虐待部分：嚴重疏忽、罵A童、不擁抱、不安撫、冷漠對待，不提供適足玩具和互動遊戲、洗冷水、不能睡等（Mira證詞及手機內容、被告社群媒體對話紀錄）
（五）嚴重疏忽及疑似性虐待：A童在1歲6個月到1歲10個月（112年9月～12月）有恐懼、空洞與悲傷的臉部表情，兒童憂鬱症（陰莖照片、民眾提供哭聲等相關證述、Mira證詞、Mira與友人傳訊紀錄）、以被告照顧時期對照112年9月前的照片，依照被告對話，A童會判（發抖）。

五、A童會自殘、罵髒話、撞頭等行為之分析（劉彩萱多次陳述）：
可信度待證，如果有，支持A童在這段時間遭受嚴重多重虐待及疏忽之事實。（無神經發展障礙、無腦神經病變的幼兒，若發生不尋常的嚴重自傷，即證明有多重虐待及疏忽之事實）

六、回溯性精神病患鑑別診斷：
暫時給予「非特定的憂鬱症」之診斷，至少已達「適應障礙併發憂鬱症」

七、創傷經驗判斷的依據基礎（資料來源）：
• 5秒影片：罰站
• 6秒影片：A童未穿衣服，另外一位兒童穿長袖
• IMG-463影片（1分45秒）：兩位兒童玩搖搖馬，A無神看著拍攝者，扶著馬頭，面容持續淡漠無變化、神情落寞憂傷、缺乏笑容、間歇數次疑懼地看著拍攝者
• 5秒影片：由鋼琴上往下拍，站著很不自然
• 41秒影片：獨坐於牆面與衣櫃間角落，黑色口罩，白色短袖上衣、短褲，緩慢遲疑
• 9秒影片：兩童坐在床上愉悅互動，身體發育均勻，沒有疤痕

※ 適應障礙症併有憂鬱情緒／憂鬱症
※ 很可能符合反應性依附障礙症（資料不足）／很可能符合創傷後壓力症（資料不足）

八、鑑定分析總結：
（一）大量多方之人證、物證支持A童確實於被告全時照顧時遭受長期嚴重多重虐待
（二）生前的精神診斷回溯：至少已達「適應障礙併發憂鬱症」，診斷「非特定的憂鬱症」
（三）創傷後壓力判斷

09:50轉證人具結
貳、證人詰問（以下就親自見聞部分為證人、具結）

檢察官主詰問	證人丘彥南醫師回答
可否理解您是很多精神科醫師的老師？	是
這是您自己寫的報告且獲得中心認可出的報告？	是

親自看過錄影帶等資料？	是
有沒有沒親自看過病人去看診的經驗？	較複雜，看直接評估或間接評估 愈小的幼童愈無法表達，要透過親近照顧者，臨床上要視發展階段
蕭保母和周保母的資料有嗎？	愈完整愈好
A童之前有可能有精神症狀嗎？	沒有
從資料看有兒童自閉症或腦神經病變？	都沒有，都不符合，不是自閉症、不是智能障礙
1歲7個月～1歲10個月的發展？	幼兒的差異性很大，最好回到案童本身的資料
稱A童會罵機掰	筆錄有看到
會是仿效他人的嗎？仿音？要多少次才會學起來？	幼兒發展階段，大概只能講2個字。之前保母說開始牙牙學語，不一定要一直在這環境裡
是否參考了Mira的證詞？	包括但不止
有聽到劉彩萱不斷餵食到想吐，一邊用愛的小手A童會哭，有使用這一段嗎？	會做綜合判斷，資料很重要。身體的傷勢鑑定會推論遭到什麼樣的待遇，用什麼工具，都會判斷
Mira的證詞「威脅」的樣態？A童在哭時，劉彩萱在他耳邊講話，之後聲音就停下來，表情害怕	
辯護人異議：誘導 審判長裁定異議成立，要先問鑑定人是否記得，不記得才能提示	
沒有被適當餵食，對發展會有什麼影響？	年齡層和長牙的階段，應該要吃固體的食物，練習咀嚼
A童怎麼被餵食？	筆錄說打成泥
用吹風機吹臉	何處的筆錄，要提示一下
劉若琳的筆錄內容，是參考這段嗎？	吹風機吹臉不是正常的育兒方式
對你的鑑定報告是肯定的嗎？	非常確定
兩位被告的責任呢？	沒有辦法做兩位或任何一位怎麼虐待的，沒有辦法100%區分，但是「共同知情」，有些可略微區分，有些是分不開的
鑑定結果呢？	適應障礙（至少達到，但不只是，有更多嚴重的） 其他：憂鬱症、高度懷疑有反應性依附障礙後創傷症候群
10:13休庭。10:27入庭	
劉彩萱辯護人反詰問	證人丘彥南醫師回答
1到2歲的幼兒和照顧者是否正在發展依附關係？	是，未出生前就有，不限於2歲前
更換照顧者，心裡會造成影響嗎？有哪些？	任何人關係改變都會，要看影響、環境……等。是要好幾堂課才能講得完的，簡單說，1歲半到2歲的幼童會有分離焦慮，改變照顧者，如何銜接轉換都需要，但也有孩子適應較好的，若照顧者差很多，不適應會較明顯
漸進式的交接，是否較好？	不管是什麼樣的幼兒，都要有良好的交接
什麼是好的交接？	充分的交接，個性、健康紀錄等，不一定是孩子在時，媒合者很重要
重點是要增加孩子的安全感及以孩子為中心嗎？	的確以孩子為中心是不變的法則
周保母跟A童的關係？	推論來說周姓保母照顧期間發展是好的，有依附的關係
交接是足夠的嗎？（只有帶去看1小時）	目前這些資訊是不足的
114年4月24日訪談裡有說，更換3個保母有無影響？	

檢察官異議	
劉若琳辯護人反詰問：沒有問題	
檢察官覆主詰問	證人丘彥南醫師回答
好的照顧者會降低分離焦慮嗎？	是的
劉彩萱的照顧有降低分離焦慮嗎？	沒有
會造成兒童的病變嗎？	不會
一般小孩子上學或送到幼兒園或托育會哭是分離焦慮嗎？	是
分離焦慮會撞頭什麼的嗎？	不會
劉彩萱辯護人覆反詰問：沒有問題 10:43休庭。11:13入庭	
國民法官（備位3號）詢問	證人丘彥南醫師回答
自傷是否就是虐待？	自殘、自傷等定義有程度上的差別，有些幼兒在入睡階段也有可能撞頭，但不會很嚴重，父母也會關心，不能說是虐待，情況也不會很嚴重，也會慢慢好起來。 臨床者要去分辨，但導致嚴重的傷害，如嚴重自閉症、智能障礙等就不太一樣。 我曾看過自閉症及妥瑞症的孩子會咬嘴唇到很嚴重到要住院，但已經9歲了
若受到虐待會否發展到讓自己自傷更嚴重？	不當對待要先考慮
國民法官（2號）詢問	證人丘彥南醫師回答
提示簡報頁35照片，A童憂傷的面容要怎麼判斷成因？	在臨床上是困難的，要比對相關資訊來源，不只這張，還有很多張，不只一個時間點，很明確地說，不是單一事件的事情，一定是持續的事情
國民法官（4號）詢問	證人丘彥南醫師回答
適應障礙症是什麼狀況？會有什麼表徵？	幼兒轉換照顧，或兒童轉換學校等壓力事件，如霸凌等，會造成焦慮等變動狀況，會使孩子不安，例如失親會有憂傷等。有些會出現焦躁或偏差行為，特別在年紀較大的孩子 3個月持續產生一些變化，和事件是有關係的，會影響他的表現等若狀況移除，可能6個月內會慢慢緩解，但若沒有好，就做另外的判斷
反應性依附障礙是什麼？	兒童精神科很特別的一個診斷類型，一般常態性的表現是會（如簡報）：A.對成人照顧者有一貫的壓抑、情感退縮行為，症狀顯示為下列兩種情況，就可能符合：1.苦惱時，極少或幾乎不尋求安慰、2.不回應安慰；B.持續社交及精神困擾
創傷後壓力症呢？	依照以下的post-traumatic stress disorder for children 6 years and younger診斷準則（DSM-V）： A.暴露於真正或具威脅性的死亡、重傷或性暴力，以下一種（或更多的）形式：1.直接經歷、2.親身目擊發生在別人身上，尤其是主要照顧者、3.父母或其他照顧者（目擊）； B.出現於事件相關的侵入性症狀：1.反覆發生不由自主及具侵擾性質的事件苦惱回憶、2.反覆出現惱人的夢，內容／情緒和事件相關、3.解離反應（例如創傷記憶閃現），感到或表現出彷彿重演，可能發生在遊戲中、4.接觸到象徵創傷事件之某層面，或相似內、外在訊息感到苦惱、5.生理反應； C.在創傷事件發生後開始持續避免與創傷事件相關的刺激，具體表現為以下一項或兩項：1.迴避或努力迴避與創傷事件有關或密切相關的痛苦記憶、想法或感受、2.逃避或努力逃避那些能喚起與創傷事件或與之密切相關的痛苦記憶、想法或感受的外在提示物（人、地點、對話、活動、物品、情境）； D.出現大於2項與事件相關警醒性與反應性的顯著改變，始於創傷事件之後等

陪席法官詢問	證人丘彥南醫師回答
提示投影片頁43，搖搖馬「無明顯迴避動作」所指為何？	實際上有看到，就這樣寫，如有覺察到有危險，會做一些反應，但A童很安靜，是很重要的「事件」
醫師強調安靜緩慢，為何會發生這樣的狀況？	可能是體能或體力不足，也有可能是鬱症，成人的呈現方式是動作緩慢、social retreat（社會退卻）
受命法官詢問	證人丘彥南醫師回答
反應依附障礙症，有創傷後鬱症等，會有擔心、不安、急躁、退縮、迴避等，如果孩子還活著的話，我們會做哪些處置？	遊戲評估、關係的建立等，讓他和熟悉的照顧者互動，日常錄影等
評估可能有心理障礙，會否有搓手、握手等舉動？	視常見的表現狀況，是不是有心理障礙，要參考所有的資料
有做過回溯性診斷嗎？	在臨床上很常見，不是不尋常的：1.在診斷除了問卷外，照顧的家長或很瞭解他的人都會是詢問對象；2.幼兒園輔導紀錄等，都可以協助運用臨床上相關的經驗來研判
審判長詢問	證人丘彥南醫師回答
施暴行為對兒童的影響？	會不斷造成明顯的影響
審判長依序詢問檢察官、辯護人、訴訟參與代理人表示意見 12:10退庭	
國民法官退席，處理保留證據裁定 審判長詢問律師是否要增加接下來的訊問時間，5月2日辯論要調整	
12:10休庭。13:32入庭	

13:32續行審理

檢察官就書證之調查

一、甲證38 鑑定報告

二、法院函詢的問與答：（一）傷勢及缺牙（牙齒及口腔部分）：傷勢成因等，（二）醫學用語、判斷標準及釋疑等、（三）死亡個案與存活個案之傷勢有何不同？

三、結論與說明：有遭受下列多重嚴重不當對待

四、精神鑑定報告：精神虐待：排斥貶損、隔離、威脅恐嚇、忽視及拒絕給予等

五、112年9月～12月可能有的情緒行為症狀資料來源來自於：房客（3樓有哭聲，長達1小時、11月28日最嚴重）、Mira等

監所關注小組 Prison Watch

100050 台北市中正區汀州路三段27巷20號3樓

prisonwatch.tw@gmail.com

TEL：(02) 2367-1436

FAX：(02) 2367-3740

監所關注小組電子報

電子郵件地址

立即訂閱